



FICHA DE INGRESO PSIQUIATRÍA INFANTO-JUVENIL

Conforme a normativa chilena – Uso Clínico

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

- Nombre: Nicolás Sáez Morales
- RUN: 26.213.591-8
- Fecha de nacimiento: 12 de abril de 2018
- Edad: 7 años
- Sexo: masculino
- Escolaridad: 2° básico, sin repitencias
- Establecimiento educacional: Colegio San Juan Evangelista
- Nombre del cuidador/tutor legal: Fernando Sáez, Carolina Morales
- Contacto:

2. MOTIVO DE CONSULTA

- Descripción del motivo de consulta: derivados por equipo psicoeduka por dificultades a nivel conductual, con avances con intervenciones de equipo pero persistencia de síntomas a nivel conductual. Dificultades en adaptación escolar.
- Tiempo de evolución: en entrevista inicial con padre da cuenta de inicio de sintomatología mas marcada al iniciar colegio presencial, durante pandemia deben recurrir a uso extenso de pantallas para mantener actividad laboral. Al reincorporarse a clases presenciales aparecen contantes desafios a los adultos, cuestiona normas, padre en ese momento director de colegio, esto el lo atribuye a que puede tomar desiciones que corresponden a los adultos, inquietud motora marcada, con pares tiende a desregularse cuando algo no le parece o no está de acuerdo, llegando a heteroagresiones hacia pares, incluso llega a morder. Padre en situacion compleja ya que presenta conflictos con apoderados siendo el director de colegio por lo que decide cambio a colegio actual. Año 2025 peristen mismas dificultades, intenta llega a acuerdos con le pero este no logra cumplir, impulsividad marcada, dificultad para autorregularse. Padres mantienen sesiones parentales pero impresiona no logran lleva a cabo lo trabajo en sesiones. Escasas estrategias de mentalización y validación emocional, tiene un perfil sensorial. Antecedente de bastante uso de pantallas e incluso videojuegos, padres ahora estarian normando mas esto. A nivel de salud mental padres describen encontrarse estables emocionalmente, en verano logran momentos de conexion emocional a nivel

familiar, si reconocen momentos de agotamiento en donde van turnando cuidados. Niegan ver triste a Nicolas, no lo notan deprimido, pero si irritable y opositor al intentar abordar con él sus dificultades. Le cuesta mucho esperar, desea todo inmediato, durante etv insiste a madre en uso de pantallas.

- Se plantea a padres inicio de apoyo farmacológico debido a que lo mas desadaptativo actualmente sería las heteroagresiones en colegio, padres se muestran de acuerdo. Explico rol de fármaco, posibles RAM.
- Se realizará coordinación con tratantes para entrega de lo observado, control en 1 mes para observar respuesta a medicamento

3. ANTECEDENTES PSIQUIÁTRICOS PERSONALES

- Diagnósticos previos: sin evaluaciones previas ni por neurología ni psiquiatría infantil
- Hospitalizaciones previas: no
- Tratamientos farmacológicos: no
- Psicoterapia previa: si, desde 2024 inician atenciones con psicología y luego TO. Además sesiones con fonoaudiología por dislalia con R tratada.
- Conductas autolesivas / ideación suicida: no, si conductas heteroagresivas con pares y adultos.

4. ANTECEDENTES MÉDICOS GENERALES

- Patologías médicas relevantes: sano
- Tratamientos actuales: no
- Alergias: no
- RAM : no

5. ANTECEDENTES FAMILIARES

- Antecedentes psiquiátricos familiares: no
- Contexto psicosocial relevante: Padres en proceso de eventual separación durante año 2024, en donde consultan con psicología. Estuvieron viviendo separados en ese entonces. Además destaca que durante pandemia padres en teletrabajo tuvieron que recurrir a bastante tiempo en pantallas de Nicolás. Luego de esto al reincorporarse a lo presencial empezaron a notar su sintomatología, su tendencia a intolerancia a los límites.

6. EVALUACIÓN DEL ESTADO MENTAL

- Apariencia: constitución mesomorfa, acorde a edad cronológica, vestimenta e
- higiene adecuada
- Actitud: inquietud motora+++, distractil, pueril. Se retira cuando se le informa que padre hablará acerca de él para poder ayudarlo.
- Psicomotricidad: se observa aumentada
- Lenguaje: Notificativo, atingente, sin alteraciones en estructura.
- Pensamiento: Sin alteraciones formales, niega delirios y niega alteraciones
- sensoperceptuales hoy.
- Ánimo impresiona eutímico
- Contacto visual escaso impresiona por distractibilidad
- Juicio de realidad: conservado, no psicótico.
- Insight: no

7. EVALUACIÓN DE RIESGO

- Riesgo suicida: no
- Factores de riesgo: exposición a pantallas y videojuegos (padres se encontrarían normandolo mas actualmente), agotamiento parental
- Factores protectores: buen nivel cognitivo de Nicolás y padres, herramientas parentales en proceso
-

8. IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA (DSM-5 / CIE-11)

- Diagnóstico principal: TDAH, tendencia a conductas opositoristas desafiantes
- Diagnósticos secundarios: Sospecha T. vincular (agotamiento parental, ambos padres con trabajos de gran carga laboral)

9. PLAN TERAPÉUTICO

- Tratamiento farmacológico: se indica iniciar azymol 1 mg/ml: 3 ml por las mañanas y observar tolerancia, reporte via mail de algun tipo de RAM
- Intervenciones psicosociales: Reforzar con padres estrategias de mentalización, validación emocional, ofrecer en momentos de frustración estrategias sensoriales de regulación emocional de acuerdo a su perfil sensorial (ej mordedores). Reforzar trabajo vincular con padres, fomentar espacio en familia de conexión emocional, psicoeducación a padre sobre síntomas propios del TDAH.
- Derivaciones: mantener TO y psicóloga, de realizará coordinación de observaciones realizadas. Eventual coordinacion escolar.
- Certificado escolar con diagnóstico y sugerencias

10. SEGUIMIENTO

- Fecha próximo control: 1 mes
- Red de apoyo: ambos padres, abuelos maternos y paternos
- Indicaciones a cuidadores: inicio de tratamiento farmacológico para facilitar actividades terapéuticas con TO y psicología.

•

11. DATOS DEL PROFESIONAL

Nombre: Caterina Schiappacasse

Especialidad: psiquiatra infanto juvenil

Registro profesional: 105595

Centro de atención: Psicoeduka Viña del Mar

Fecha: 11 de marzo de 2026